

시험 관점 코멘트



체중 감소의 경우 키, 몸무게, 허리둘레를 정확하게 확인하고, 얼마만큼의 기간 동안 몇 kg가 빠졌는지 확인하는 것이 우선입니다. 6~12개월 사이에 5% 이상의 체중 변화나 5kg 이상 감소, 혹은 한 달에 2kg 이상의 체중 감소가 있을 경우 의미 있는 체중 변화로 간주할 수 있습니다. 이후 수의적, 불수의적 원인으로 나누어 운동량과 식사량의 변화를 확인하여 의도적으로 식사량을 줄여 체중을 줄인 경우나 씹는 데에 장애가 있어 먹지 못한 경우 등을 먼저 감별해야 합니다. 이후 불수의적 원인으로 호흡기/내분비/소화기로 나누어 생각하고, 암의 가능성을 떠올리며 질문하면 좋습니다.

식습관과 평소 운동 습관에 대해 꼼꼼히 물어본 뒤 교육 시간에 개선해야 할 점을 상세하게 알려주면 환자-의사 관계가 좋아질 것입니다. 신체 검진에서는 환자가 호소하는 증상에 맞게 필요한 신체 검진을 선택적으로 시행해야 합니다.

결핵이 의심될 경우 흉부 진찰을 full로 하도록 합니다. 교육 시에는 의미 있는 체중 감소를 설명하고, 체중이 더 빠지기 전에 병원에 잘 왔다고 환자에게 안심시킨 후 열량 섭취 부족하지 않도록 하루 3끼 규칙적이고 충분한 식사를 하도록 교육합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

* 의미있는 체중 저하 : 6~12개월 사이에 5% 이상의 체중 변화나 5kg 이상 감소/한 달에 2kg

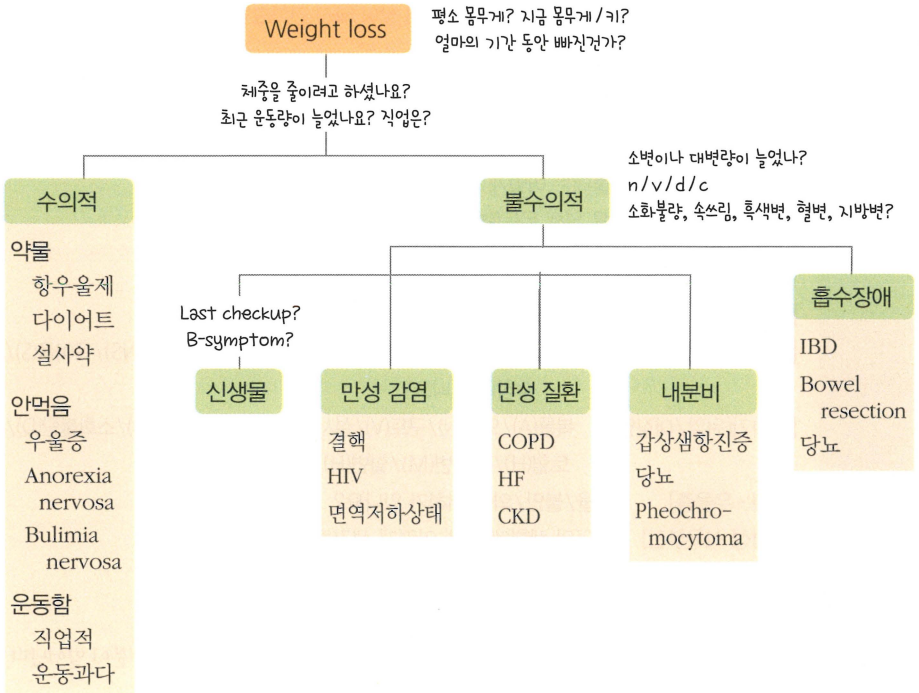
1) 체중 감소가 의미있는지? 2) 수의적/불수의적? 3) 칼로리 섭취가 감소했는지? 먼저 확인

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
일차성	일차성 체중 감소	[병력] 스트레스 해소와 식습관 개선을 통해 체중 증가 필요	[치료] 생활 습관 개선
약물	약물 유발 체중 감소	[병력] 설사약 등	[치료] 약물 중단
호흡기	폐결핵★ (tuberculosis)	[병력] 발열, 객혈, 피로, 체중 감소, 야간 발한, 이전에 결핵 걸렸던 적 있음 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 객담 항산염색, 투베르쿨린 검사 [치료] 항결핵제(Isoniazid, Rifampin, Pyrazinamide, Ethambutol)

호흡기	만성 폐쇄 폐질환 (chronic obstructive pulmonary disease) /폐암	[병력] 고령, 가래, 흡연자, 호흡곤란, 객혈 [검진] 흉부 청진에서 싹싹거림 가능	[검사] 폐기능검사, CXR, ABGA [치료] SABA, LABA, LAMA, 산소 치료
내분비	당뇨병★ (diabetes)	[병력] 다뇨, 다갈, 체중 감소, 피로, 소변에서 단내, 가족 중 당뇨 [검진] 별다른 이상 소견 없음	[검사] 혈중 포도당, 당화혈색소, 소변검사 [치료] Metformin 등 혈당강하제, 인슐린 주사, 식습관 조절
	갑상샘항진증★ (hyperthyroidism)	[병력] 체중 감소, 더위불내성, 설사, 피로 [검진] 갑상샘 촉진	[검사] TFT [치료] Propylthiouracil, Methimazole, 방사성 요오드 치료
	크롬친화세포종 (pheochromocytoma)	[병력] 두통, 안면 홍조, 발한, 두근거림, 식은땀, 기립성 저혈압 [검진] 복부 촉진	[검사] 24시간 요중 메타네프린, 복부 CT [치료] Phenoxybenzamine, Propranolol, 부신절제술
소화기	위암/대장암	[병력] 체중 감소, 소화불량, 혈변/흑색변, 이전 위내시경에서 궤양 [검진] DRE	[검사] 위내시경, 복부 CT [치료] 위절제술, 내시경적 점막 하절제술, 항암 치료
	짧은장증후군 (short bowel syndrome)	[병력] 이전 수술로 장 절제함 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 복부초음파, 단순 복부 방사선 촬영 [치료] TPN, 지사제, Cholestyramine
	염증 장질환★ (IBD)	[병력] 혈변, 심한 복통, 탈수, 체중 감소 [검진] 복부 압통, 장음 감소, DRE 혈변	[검사] 대장내시경, 대장조영술, 복부 CT [치료] 설파살라진, 스테로이드, Infliximab, 충분한 영양 공급
기타	기생충 감염	[병력] 해외여행력, 익히지 않은 음식 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 대변검사 [치료] 구충제(praziquantel)
정신	우울증	[병력] 우울, 의욕 저하, 식욕부진, 수면장애, 죄책감, 집중력 저하, 사고력장애, 정신운동초조	[검사] Beck의 우울척도검사 [치료] SSRI, TCA, 전기경련요법

정신	신경성 식욕부진★ (anorexia nervosa)	[병력] 타의로 내원, 본인이 살았다고 생각, 젊은 여성, 생리 불규칙, 구토제 사용 [검진] 구토 흔적(Russel's sign)	[검사] 전해질검사 [치료] 영양 공급 및 입원 치료
----	---------------------------------	--	--

증례별 알고리즘



Physical

신장/체중 측정 → BMI 계산
피부, 구강, 혀, 치아 상태 확인
눈(창백? 황달? 돌출?)

갑상샘 비대?
목이나 겨드랑이 림프절
가슴 청진(심폐 기능)

다리 오목부종
복부 진찰(시청타촉, 간비종대, 종괴)
DRE(if needed)

기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 체중이 빠지기 시작했나요?/체중이 빠진 것을 안게 언제였나요? 체중이 얼마나 줄었나요?
L	살이 특히 더 빠진 부위가 있나요?
D	지속적으로 살이 빠지셨나요?/아니면 갑자기 살이 빠진 건가요?
Co	몇 kg에서 몇 kg으로 살이 빠지셨나요?
Ex	이전에도 이렇게 살이 많이 빠진 적이 있나요?
C	현재 키, 몸무게, 허리둘레는 어떻게 되나요? 인위적으로 체중 감소를 위해 운동량/식사량 조절을 하셨나요?
A	[전신] 발열/오한/피로 [흡수 부족] 씹는데 장애가 있으신가요? [호흡기(결핵/폐암/COPD)] 기침(C)/가래(S)/객혈(H)/호흡곤란/야간 발한(NS)/목아픔(S)/숨참이 있나요? [소화기(위암/대장암)] 복통(A)/오심(N)/구토(V)/설사(D)/변비(C)/속쓰림(H)/소화불량(D)/토혈(H)/흑색변(M)/혈변(H)/지방변이 있나요? [정신 - 우울증] 우울/불안/의욕 저하가 있나요? [신경성 식욕부진] 본인의 체형에 대해 어떻게 생각하시나요? 스스로 뚱뚱하다고 생각하시나요? 일부로 구토를 한 적이 있나요? [암기법] 체중 감소로 온 환자가 씹질 못해 전신 흡수 부족을 호소하며 정신의 내분이 일어났다. [설명] ANVDC HD HMH 형태 [갑상샘항진증] 더위불내성/두근거림/설사가 있나요? [크론친화세포증] 두통/두근거림/발한/기립성 저혈압이 있나요? [당뇨] 다음/다갈/다뇨가 있나요? [암기법] 내분비 과다로 갑자기 크당
F	[가생충] 해외 여행을 다녀오셨나요? 최근에 스트레스 받는 일이 있나요?
E	이전에 건강 검진 받은 적 있나요? → 위내시경/대장내시경 받아 보았는지?

외	[수술] 위나 대장 수술을 받으신 적 있나요? (short bowel syndrom)
과	고혈압/당뇨/간질환/갑상샘 질환이 있나요? 과거 정신건강의학과 진료를 받은 적이 있나요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? → 항우울제, 다이어트약, 설사약 등
사	직업이 어떻게 되시나요? (직업 활동에 육체적 활동량은 얼마나 되는지 확인) 술은 드시나요?/흡연은 하시나요? [식습관] 식사는 규칙적으로 하시나요? 식사량은 어느 정도 되나요? 외식은 많이 하시나요? 육류와 기름진 음식을 좋아하시나요? (주로 어떤 걸 드시나요?) [운동] 평소 운동은 규칙적으로 하세요? 최근에 운동량이 늘었나요?
가	가족 중에 당뇨나 고혈압을 앓고 계신 분이 있나요? 가족 중 암에 걸리신 분이 있나요?
여	[월경력] 규칙적/생리 주기/생리량/월경통/LMP는 언제인가요? [산과력] 임신 가능성이 있나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). 가장 먼저 키/체중/허리둘레 확인 or 측정★ [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달), 안구 돌출 2. 입★: 구강, 치아(신경성 식욕부진, 토혈 흔적 확인) 3. 목★: 갑상샘 촉진, 림프절 비대(암) 4. 흉부 진찰 : 심음, 호흡음 청진(결핵, 폐암) [누워서] 5. 복부 진찰★: 시-청-타-촉 (간, 비 종대 및 종괴 유무 확인) 6. 사지 : 피부 긴장도(탈수)
술기	[임상 술기] 모형이 준비되어 있음 1. 항문 직장 진찰 → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 점은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	갑자기 살이 빠지셔서 많이 걱정이 되셨겠어요?
추정 진단	체중이 6개월 동안 평소 체중의 5% 이상 또는 5kg 이상 감소하였기 때문에 의미 있는 체중 감소로 보입니다. 하지만 지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 현재 특정한 기질적 이상 소견이 없는 것으로 보아 일차성 체중 감소가 가장 의심되므로 너무 걱정은 안 하셔도 될 것 같습니다.
감별 진단	하지만 이 외에도 당뇨, 갑상샘항진증, 결핵 등 다양한 체중 감소의 원인들을 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 공복혈당검사, 갑상샘기능검사, 소변검사, 흉부 X선 검사 등을 시행하고자 합니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 이런 검사에서 체중 감소가 기저 질환에 의한 것으로 밝혀질 경우에는 원인 질환 치료를 통해 체중 조절이 가능합니다.
예후	더 살이 많이 빠지기 전에 병원에 잘 방문해 주셔서 같이 치료해 볼 수 있을 것 같아요. 병원에 잘 오셨습니다.
교육	[생활 습관 개선] 기질적인 원인이 없는 체중 감소에서는 특히 스트레스 해소나 식습관 개선을 통한 체중 증가가 중요합니다. 열량 섭취가 부족하지 않도록 정해진 시간에 하루 3끼 규칙적인 식사를 하시고, 스트레스를 줄여 나갈 수 있도록 취미 생활을 하거나 적당한 휴식을 취하는 것도 체중 증가에 도움이 되실 거라고 생각합니다. [거식증] 심한 체중 감소로는 골다공증, 불임, 근력 약화 등이 유발되어 매우 위험할 수 있습니다. 치료를 통해 과도하게 살을 찌우는 것이 아니라 정상 체중으로 돌아가는 것이고, 의학적으로나 정신적으로 꼭 필요한 것이므로 꼭 치료를 받으셔야 합니다. [당뇨] 합병증이 오지 않도록 치료하는 것이 중요하고, 경구혈당강하제를 사용해 볼 수 있겠으며, 식습관 개선 등 생활 습관의 변화도 필요합니다.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, 전해질, TFT, 공복 혈당, HbA1c
- ② 소변검사 : 24시간 메타네프린, 임신반응검사
- ③ BDI 우울증 척도검사(신경성 식욕부진은 다른걸 DDx하고 증상 있으면 진단)
- ④ 여성 : LH, FSH, 에스트로겐, 프로게스테론
- ⑤ 대장내시경, 대장조영술
- ⑥ 객담 AFB 염색

❖ 치료 계획

- ① 체중 증가, 영양 회복(식사 형태 교정)
- ② 갑상샘 기능 과다 : PTU(propylthiouracil), MTZ(methimazole)
- ③ 크론병, UC : 5-ASA, glucocorticoid, 대장절제술, 자극주는 커피/탄산 피하기

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 불수의적 체중 감소의 경우 환자가 불안해할 수 있으므로 안심시키고 추가적 검사의 필요성 설명
- ② 당뇨의 경우 합병증 오지 않도록 혈당 관리의 중요성에 대해 설명(생활 습관 개선 및 약 복용)
- ③ 신경성 식욕부진의 경우 자신에 대해 잘못된 인상을 가지고 있으면 교정해 주고, 예상되는 몸무게에 20% 이하인 경우나 내과적 문제가 심각한 경우 입원을 권유



keyword

키, 몸무게, 허리둘레를 정확하게 확인하고, 얼마만큼의 기간동안 얼마만큼의 체중 감소가 있었는지 확인하기

수의적(약물, 식이요법, 섭식장애, 운동과다), 불수의적(호흡기, 내분비, 소화기, 암) 원인으로 나누어 감별하기

결핵이 의심되면 흉부 진찰 full로 하기

수의적 체중 감소 환자에게 규칙적 식사와 건강한 방법으로 스트레스를 해소하며, 당뇨가 있을 경우 철저한 혈당 관리를 교육하기